جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ساميه محمد سيد جمعه
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** العمرانيه **العنوان :** 50 ش التضامن
رقم البطاقة : 25911142100042 **رقم التليفون :** 01152754503 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 14-11-1959 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ساميه محمد سيد جمعه
National ID: 25911142100042

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

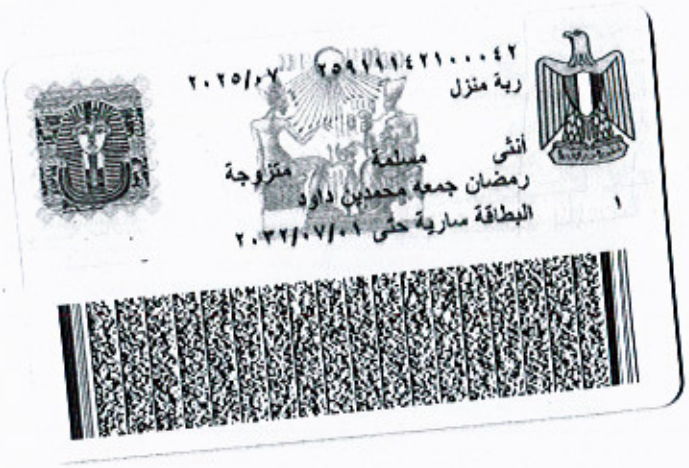
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Bone scintigraphy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

جمعية الأمراض الحميدة المتخصصة
مركز أورام دار السلام
إدارة المعمل
قسم الباثولوجي

Pathology Report

Name: [illegible] Age: 60 years.

Clinical data: Right breast mass.

Specimen type: Tru cut biopsy.

Date: 12/7/2020

Lab. Number: 976 Hospital Number: 2-102/2020

Gross Description:

Five greyish white, focally fatty tissue cores; 1.3 cm each, totally submitted.

Microscopic Examination:

Histopathological examination of section prepared reveled breast tissue cores, infiltrated by invasive malignant tumor, formed of cords of moderately anaplastic ductal epithelial cells, with desmoplastic stroma.

Diagnosis:

Right breast mass, tru cut biopsy;
Invasive duct carcinoma GII, for IPT; (ER, PR, Her2 & Ki67).

Prof. Dr. Gamal Abdel-Aty
Dr. Enas Mohamed Ali

Prof. Dr. Essam Ayad

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient name: Samia Mohammad Saied Gomaa
Date: 23.11.2020

DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

Indication:

Patient is 61years old and is seen for follow-up after NACT for a known right breast cancer

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Predominantly fatty breast parenchyma (ACR a)
- Right Breast:
  - A metallic clip is seen in the [illegible] region (around 6 O'clock, deep retro-areola). No related mass or malignant microcalcifications
  - Ultrasound shows no mass or cyst
  - No pathologically enlarged axillary LNs
- Left Breast:
  - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
  - A focus of benign pop-corn calcification is noted
  - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
  - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
  - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post NACT status of right breast showing no residual lesion (BIRADS 6: with complete radiological response)
- Normal sonomammography of Left breast except for benign macrocalcification (BIRADS 2)

Best regards,
Dr. Amira H Baowan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient name: Samya Mohamed

Date: 6/7/2020

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

Right breast palpable lump 2 months ago

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Right breast shows LOQ irregular spiculated mass lesion, of high density
- Complementary ultrasound revealed right breast irregular spiculated hypoechoic mass lesion, with subtle vascularity detected within on color Doppler seen at 6 to 7 o'clock position 4cm from the nipple, 0.7 cm from the skin, measuring 1.7x1.8x3.1cm, consistent to the palpable lump.
- Normal skin thickness and nipple areola complex
- Pathological ipsilateral right axillary lymphadenopathy seen with effaced hilum the largest is seen measuring 3.9x4.1cm
- Free right infra and supra clavicular regions
- Non specific left axillary LN

Opinion:

- Right breast LOQ malignant looking mass lesion (BiRADS 5) for histopathological correlation.

Yours truly

Dr Engy Abdallah

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number m3847

	Female	النوع	
	القاهرة	العنوان	
	21/07/2020 08:44	تاريخ استلام العينة	
	28/07/2020 10:29	تاريخ التقرير	
	مركز اورام دار السلام	مكان التحليل	
	مركز اورام دار السلام	عيادة	

Primary Sample

Paraffin Block

Test :

ER &PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

Sample recieved was treated by : CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (1E2)Rabbit monoclonal primary antibody

Sample recieved was treated by : -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX

Sample recived was treated by :- CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody

Result :

ER No nuclear staining of tumour cells (core biopsy)

PR moderate nuclear staining of 20 % of tumour cells (core biopsy)

HER2/neu protein over expression No membrane staining of tumour cells. (core biopsy)

Ki67 positive nuclear staining of about 60 % of tumour cells (core biopsy)

Referal Lab :

Comment :

Conclusion :

ER NEGATIVE
PR POSITIVE (SCORE 5/8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION NEGATIVE
#Ki67 THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ABOUT 60 %

Pathologist

Lab Director

19 Elsheikh Rehan Street, Abdeen, Cairo
Tel (002)02948541 -26900556 Fax (202)2948544
Mobile 01144292292
website http://www.healthlabs.net
email:labslab@tiffy.net.com
facebook

This Test Is Not Covered by Egypt National Health Insurance

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

مستشفى أورام دار السلام
قسم الباثولوجي

Pathology Report

Name: [illegible] Age: 60 years.

Clinical data: Rt breast cancer, Post chemotherapy.

Specimen type: Right breast wide local excision WLE specimen.

Date (Received):22/4/2021 Date(reported): 5/5/2021

Lab. Number: 889/21 Hospital Number:

Gross Description:

1- Sector of mammary tissue, wire guided showed rubbery greyish white mass measured 0.5x.05cm away from medial margin by 1cm. Least margin showed tiny indurated focus measured 0.3x0.3cm. Margins were free grossly.
2- Axillary fat clearance: Fibrofatty tissue piece measured 8x4cm, enclosing 12 nodules up to 1.5cm.

Microscopic picture:

Sections examined revealed extensive fibrosis and hyalinosis all over, with focal adenosis and cystically dilated ducts showing apocrine metaplasia, with focal florid epitheliosis.
The ducts are lined by inner columnar and outer myoepithelial cells.
No malignant cells were detected.
Free resection margins.
Free lymph nodes with therapy-induced changes in 3 nodes, (0/12).

Diagnosis:

Right breast WLE specimen.
Totally burned-out tumour (complete pathological response).
Tumour necrosis index 100%
Free resection margins.
Free lymph nodes with therapy-induced changes in 3 nodes, (0/12).
Stage: yTx, yN0, yMx

Prof. Dr. Lubna Omar.
Dr. Abdulrahman Ibrahim.

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]